



COLLANA EDITORIALE

POLICY REPORT 02 • 2026

FVG Smoke-Free

Scienza, riduzione del danno e
politiche pubbliche per un
Friuli Venezia Giulia smoke-free

SCIENZA • PREVENZIONE • POLITICHE REGIONALI

POLICY REPORT 02

FVG SMOKE-FREE

Scienza, riduzione del danno e politiche pubbliche per un Friuli Venezia Giulia smoke-free

FONDAZIONE BOSCACCI ETS

ENTE	Fondazione Boscacci ETS
DATA	Ottobre 2026
CODICE	PR/02/2026
AMBITO	Salute pubblica · tabagismo · prevenzione · riduzione del danno · politiche regionali

CONTESTO DI ORIGINE

Il paper rielabora in chiave di policy i contenuti della roundtable “FVG Smoke-Free - Un dialogo tra Scienza e Politica”, svoltasi il 21 ottobre 2025 presso la Sala degli Stucchi di Trieste. L'incontro ha riunito istituzioni regionali, comunità scientifica, accademia e industria attorno ai temi della prevenzione del tabagismo, della Tobacco Harm Reduction (THR), dell'innovazione e della collaborazione pubblico-privato.

01 Executive Summary

Il Friuli Venezia Giulia presenta una prevalenza del fumo ancora significativa e, al tempo stesso, dispone di condizioni favorevoli per sperimentare un approccio più integrato alle politiche sul tabagismo. La roundtable FVG Smoke-Free ha messo a confronto dati regionali, pratiche di cessazione, strategie di prevenzione, modelli internazionali di riduzione del danno e impatti economici dell'innovazione industriale.

Dal confronto emerge una possibile architettura di policy fondata su quattro assi: prevenzione dell'iniziazione, rafforzamento della cessazione, valutazione evidence-based delle strategie di riduzione del danno per i fumatori adulti che non smettono, e monitoraggio regionale continuo. Il documento propone di tradurre questa impostazione in una survey regionale, in un percorso ECM rivolto ai Medici di Medicina Generale e in una rete stabile tra MMG, servizi di prevenzione, centri antifumo e farmacie.

MESSAGGIO CHIAVE

Il passaggio da iniziative isolate a una strategia regionale richiede dati aggiornati, criteri scientifici trasparenti, protezione rigorosa dei minori, sostegno alla cessazione e una governance capace di misurare gli esiti nel tempo.

Cinque priorità operative

- Aggiornare il quadro epidemiologico regionale con dati più granulari su prevalenza, tentativi di cessazione, uso di prodotti alternativi e percezione del rischio.
- Rafforzare il ruolo dei Medici di Medicina Generale nel counselling breve e nell'invio ai servizi di cessazione.
- Integrare prevenzione, cessazione e riduzione del danno in una cornice unica, distinguendo nettamente la protezione dei non fumatori e dei giovani dalla gestione del rischio nei fumatori adulti.
- Costruire indicatori regionali di processo e di esito, pubblicati con cadenza annuale.
- Mantenere trasparente la distinzione tra evidenze indipendenti, studi presentati dagli stakeholder e posizioni dell'industria.

02 Il quadro regionale

Nel corso dell'evento sono stati presentati dati non perfettamente coincidenti sulla prevalenza del fumo in Friuli Venezia Giulia: una presentazione regionale ha indicato il 25% degli adulti e il 10% degli anziani, mentre l'intervento di Fabio Beatrice, richiamando dati PASSI, ha indicato il 22% della popolazione regionale. La differenza va letta come indicazione della necessità di allineare fonti, periodi di osservazione e definizioni prima di costruire target di policy.

Indicatore discusso	Dato riportato nell'evento
Prevalenza fumatori adulti	25% nella presentazione regionale; 22% nell'intervento basato su PASSI
Tentativi di cessazione	31% dei fumatori nel biennio 2023-2024; 13% indicato come riuscito
Uso di dispositivi alternativi	8% indicato nella presentazione regionale
E-cig	5% in FVG vs 4% media nazionale, secondo la presentazione regionale
Centri antifumo	Copertura indicata come inferiore allo 0,1% dei fumatori nell'intervento di Fabio Beatrice

Questi elementi suggeriscono che una strategia regionale dovrebbe partire da una base dati condivisa, aggiornata e replicabile, evitando di costruire obiettivi su indicatori provenienti da fonti o periodi non omogenei.

PRINCIPIO DI METODO

Prima di definire obiettivi regionali quantitativi è opportuno armonizzare le fonti epidemiologiche e rendere pubblici definizioni, popolazioni di riferimento e periodi di rilevazione.

03 Prevenzione, cessazione e riduzione del danno

La roundtable ha discusso la Tobacco Harm Reduction come possibile componente aggiuntiva delle politiche sul tabagismo. Nel materiale dell'evento, Fabio Beatrice e James J. Murphy hanno richiamato pubblicazioni e modelli internazionali a sostegno del passaggio dai prodotti combustibili a prodotti senza combustione per fumatori adulti che non smettono. Alcune stime quantitative riportate nel corso degli interventi - inclusa l'indicazione di una tossicità "fino al 95% in meno" - devono essere lette come affermazioni presentate dai relatori e non come conclusioni autonome di questo paper.

Una cornice a tre livelli

- 1. Prevenzione** impedire l'iniziazione, con particolare attenzione ai minori e ai non fumatori.
- 2. Cessazione** aumentare l'accesso a counselling, percorsi clinici, farmacoterapia quando appropriata e centri antifumo.
- 3. Riduzione del danno** valutare, con criteri scientifici e regolatori trasparenti, opzioni destinate esclusivamente ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.

Questa impostazione evita di confondere la riduzione del rischio con una normalizzazione dell'uso di nicotina e mantiene prioritaria la cessazione completa. Allo stesso tempo consente di discutere in modo pragmatico le scelte dei fumatori adulti che non riescono a smettere.

CONDIZIONE NON NEGOZIABILE

Qualunque strategia di riduzione del danno deve convivere con misure robuste contro l'accesso dei minori, comunicazioni non promozionali e monitoraggio indipendente degli effetti sulla popolazione.

04 Il riferimento svedese e il quadro europeo

Più interventi hanno richiamato la Svezia come caso di studio. Nel materiale della roundtable sono stati citati valori di prevalenza del fumo attorno al 5-6% e una mortalità per patologie correlate al tabacco inferiore alla media europea. Questi elementi sono stati usati dai relatori per sostenere politiche differenziate per rischio e una maggiore disponibilità di alternative senza combustione.

Il confronto europeo resta però più ampio: regolazione dei prodotti, tassazione, tutela dei consumatori, prevenzione giovanile e obiettivi di salute pubblica devono essere considerati insieme. Il report richiama inoltre i dossier europei TED e TPD e collega il tema agli obiettivi UE su malattie cardiovascolari e cancro.

Implicazioni per la Regione

- Usare i confronti internazionali come benchmark, non come modelli automaticamente trasferibili.
- Separare chiaramente dati osservazionali, ipotesi causali e proiezioni di impatto.
- Valutare l'effetto di eventuali politiche regionali attraverso indicatori predefiniti e verificabili.
- Coordinare ogni iniziativa regionale con il quadro regolatorio nazionale ed europeo.

05 Innovazione, industria e territorio

La roundtable ha incluso una dimensione economica e industriale. Alberto Dreassi ha presentato uno studio sull'impatto di BAT Trieste per il 2023-2024, mentre Pierre Durinck ha illustrato il percorso di trasformazione industriale e gli investimenti nell'Innovation Hub di Trieste. Si tratta di contenuti utili per comprendere il rapporto tra innovazione, occupazione e filiere territoriali, ma che vanno tenuti distinti dalla valutazione sanitaria dei prodotti.

Indicatore presentato	Valore riportato
Investimenti BAT Trieste 2023-2024	Oltre 160 milioni di euro, secondo lo studio presentato da Alberto Dreassi
Valore aggiunto	15 milioni nel 2023 e 18 milioni nel 2024
Quota al personale	65% del valore aggiunto, secondo la presentazione
Valore trattenuto in FVG	Oltre l'85%, secondo la presentazione
Fornitori	Da circa 100 a 350 in un anno, per 95 milioni di euro di controvalore
Innovation Hub	Investimenti indicati in 500 milioni di euro e 16 linee produttive nell'intervento di Pierre Durinck

LETTURA CORRETTA

Gli indicatori economici mostrano il peso territoriale degli investimenti, ma non costituiscono evidenza dell'impatto sanitario dei prodotti. Le due dimensioni devono essere valutate con metodologie distinte.

06 Una piattaforma regionale di conoscenza

Il materiale dell'evento propone una Survey Regionale FVG Smoke-Free per aggiornare i dati PASSI, coinvolgere i Medici di Medicina Generale e integrare la formazione ECM. L'idea può diventare il perno operativo di una strategia regionale misurabile.

Architettura proposta

Target	Strumento	Finalità
Cittadini 18-69 anni	Questionario tramite MMG e ASL	Abitudini di fumo, tentativi di cessazione, uso di e-cig e altri prodotti
Medici di Medicina Generale	Survey online + focus group ECM	Counselling, percezioni, bisogni formativi
Operatori sanitari	Intervista qualitativa	Collaborazione con MMG e barriere operative
Farmacie	Questionario breve	Richieste relative a cessazione e prodotti alternativi

Corso ECM - Il Medico di Base e la Strategia Smoke-Free

Il documento propone un corso FAD di 4 ore e 4 crediti ECM, con moduli su epidemiologia del tabagismo in FVG, dipendenza da nicotina, differenze tossicologiche tra combustione e prodotti senza combustione, evidenze cliniche, counselling motivazionale breve, integrazione MMG-centri antifumo-farmacie, comunicazione del rischio e casi pratici.

07 Raccomandazioni di policy

- 1. Istituire un coordinamento regionale permanente sul tabagismo** - con Regione, servizi di prevenzione, MMG, centri antifumo, farmacie, università e rappresentanti della società civile.
- 2. Realizzare la Survey Regionale FVG Smoke-Free** - con protocollo metodologico pubblico e indicatori comparabili nel tempo.
- 3. Potenziare la cessazione** - aumentando l'accessibilità ai servizi e integrando il counselling breve nella medicina territoriale.
- 4. Distinguere target e messaggi** - protezione dei minori e dei non fumatori da una parte; gestione del rischio nei fumatori adulti dall'altra.
- 5. Valutare la riduzione del danno con criteri evidence-based** - separando evidenze indipendenti, studi industriali e posizioni degli stakeholder.
- 6. Costruire un programma ECM regionale** - per allineare competenze cliniche e comunicazione del rischio tra professionisti.
- 7. Pubblicare un Report annuale FVG Smoke-Free** - con andamento degli indicatori, attività realizzate, criticità e raccomandazioni.
- 8. Rafforzare la prevenzione giovanile** - monitorando accesso, percezioni e pattern di utilizzo di prodotti contenenti nicotina.
- 9. Valutare gli impatti economici separatamente dagli impatti sanitari** - utilizzando metodologie dedicate e dichiarando fonti e potenziali conflitti di interesse.
- 10. Collegare la strategia regionale al quadro nazionale ed europeo** - in particolare ai dossier regolatori su prodotti del tabacco e fiscalità.

08 Governance, indicatori e output

Per trasformare il confronto di Trieste in una politica pubblica replicabile, il programma dovrebbe essere accompagnato da una governance semplice e da un set limitato di indicatori misurabili.

Output attesi

- Report annuale FVG Smoke-Free 2026 con analisi e raccomandazioni operative.
- Piattaforma o sistema digitale di monitoraggio dei pazienti fumatori seguiti dai MMG, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
- Proposta di policy regionale che definisca il rapporto tra prevenzione, cessazione e valutazione della riduzione del rischio.
- Percorso ECM per la medicina territoriale e strumenti condivisi di counselling.
- Cruscotto regionale con indicatori di prevalenza, cessazione, accesso ai servizi e outcome.

Indicatori essenziali

- Prevalenza di fumatori adulti e giovani
- Quota di fumatori che tentano di smettere
- Quota di cessazioni a 6 e 12 mesi
- Accessi ai centri antifumo e invii da MMG
- Copertura dei programmi ECM
- Percezione del rischio e conoscenze sulla nicotina
- Utilizzo di prodotti alternativi tra fumatori, ex fumatori e non fumatori
- Indicatori di accesso dei minori e prevenzione

09 Conclusioni

Il Friuli Venezia Giulia può utilizzare il percorso FVG Smoke-Free come laboratorio di policy, a condizione che il confronto tra istituzioni, scienza, professionisti e imprese sia tradotto in strumenti trasparenti, misurabili e verificabili. La priorità resta ridurre il peso sanitario del fumo, aumentare le cessazioni e prevenire nuove dipendenze.

La riduzione del danno, così come discussa nella roundtable, può essere oggetto di valutazione all'interno di questa cornice, ma non sostituisce né la prevenzione né la cessazione. La qualità della strategia dipenderà dalla capacità di distinguere chiaramente le evidenze scientifiche dalle posizioni degli stakeholder e di misurare gli effetti reali sulla popolazione regionale.

PROPOSTA FINALE

Avviare nel 2026 un programma FVG Smoke-Free articolato in: survey regionale, formazione ECM dei MMG, rete integrata di counselling e cessazione, monitoraggio annuale e tavolo tecnico regionale con regole di trasparenza sulle fonti e sui conflitti di interesse.

Nota metodologica

Questo Policy Report è una rielaborazione editoriale e di policy del materiale della roundtable del 21 ottobre 2025. I dati, le stime e le affermazioni quantitative attribuite ai relatori sono riportati come contenuti presentati durante l'evento; il documento non sostituisce una revisione sistematica della letteratura né una validazione indipendente delle singole stime.

FONDAZIONE BOSCACCI ETS

POLICY REPORT 02

FVG Smoke-Free

Scienza, riduzione del danno e politiche pubbliche per un Friuli Venezia
Giulia smoke-free

Fondazione Boscacci ETS

Via Carlo Noè 45 • Gallarate (VA)
www.boscacci.it • info@boscacci.it
Repertorio RUNTS 152268